



Institute for The Study Of Humanity

Tutkimusohjelma, jota ylläpitää suomalainen rekisteröity yhdistys Maximized Impact ry. Helsinki.

Väliraportti

Study 7: puhelinkammo ja puhelujen välttely

464 vastausta ajalta 28.9.–7.10.2026 · Raportti päivätty 9.10.2026

Käynnissä olevan tutkimuksen alustava tulos. Luvut kuvaavat kyselyyn vastanneita, eivät koko väestöä.

Tämä on ensimmäinen katsaus Study 7 - Stage A -kyselyn tuloksiin. Anonyymi kysely selvittää, miltä puhelut tuntuvat aikuisista, joilla on ADHD, autismi, kumpikin (AuDHD) tai ei kumpaakaan. Mukana ovat kaikki vastaukset, jotka saapuivat ennen 8.10.2026 klo 00.00 Suomen aikaa. Katkaisuhetki kirjattiin esirekisteröintiin ennen tiedonkeruun alkua.

Tietääksemme yhdessäkään julkaistussa tutkimuksessa ei ole mitattu, kuinka yleisiä puhelinkammo ja puhelujen välttely ovat aikuisilla, joilla on ADHD, tai autistisilla aikuisilla. Kysely on edelleen auki, ja ensimmäisen aallon raportti julkaistaan 31.10.2026 jälkeen.

Pääluvut

Mittari	Kaikki 464 vastaajaa
Puhelinkammo, laaja määritelmä Vastasi usein tai aina ainakin toiseen väittämistä ”Kun puhelimeni soi, jännitän tai ahdistun” ja ”Ahdistun ennen puhelua, joka minun on soitettava”, tai arvioi puhelujen aiheuttaman ahdistuksen vähintään arvoon 7 asteikolla 0–10. Tämä on tutkimuksen päämittari.	71 % 95 %:n luottamusväli 67–75
Puhelinkammo, tiukka määritelmä Vastasi usein tai aina molempiin väittämiin.	51 % 95 %:n luottamusväli 46–55
Puhelujen välttely Vastasi usein tai aina ainakin toiseen väittämistä ”Jätän vastaamatta tuttujen ihmisten puheluihin sen takia, miltä puhelut minusta tuntuvat” ja ”Lykkään takaisin soittamista päivän tai pidempään”, tai oli viimeisen vuoden aikana vältellyt jotain tärkeää, koska se olisi vaatinut puhelun.	80 % 95 %:n luottamusväli 76–83

Ryhmittäin

Jokainen vastaaja ilmoitti itse, onko hänellä ADHD tai autismi: diagnosoitu, epäilty (tutkimuksissa, tai ei diagnoosia mutta tunnistaa itsessään tai epäilee) tai ei. Kontrolliryhmää ei ole. Jokainen ryhmä kuvataan omana ryhmänään.

Ryhmä	n	Puhelinkammo, laaja	Puhelinkammo, tiukka	Puhelujen välttely
Kaikki vastaajat	464	71 % (67–75)	51 % (46–55)	80 % (76–83)
ADHD diagnosoitu, autismi diagnosoitu (AuDHD)	48	98 % (89–100)	77 % (63–87)	98 % (89–100)
ADHD diagnosoitu, autismi epäilty	88	83 % (74–89)	67 % (57–76)	90 % (82–95)
ADHD diagnosoitu, ei autismia (vain ADHD)	30	63 % (46–78)	40 % (25–58)	77 % (59–88)
ADHD epäilty, autismi diagnosoitu	13	85 % (58–96)	54 % (29–77)	92 % (67–99)
ADHD epäilty, autismi epäilty	100	76 % (67–83)	58 % (48–67)	83 % (74–89)
ADHD epäilty, ei autismia	50	48 % (35–61)	22 % (13–35)	66 % (52–78)
Ei ADHD:ta, autismi diagnosoitu (vain autismi)	21	90 % (71–97)	81 % (60–92)	81 % (60–92)
Ei ADHD:ta, autismi epäilty	35	86 % (71–94)	63 % (46–77)	91 % (78–97)
Ei ADHD:ta, ei autismia (ei kumpaakaan)	79	41 % (30–52)	15 % (9–25)	56 % (45–66)
<i>Kaikki, joilla on ADHD-diagnoosi</i>	166	84 % (77–89)	65 % (58–72)	90 % (84–94)
<i>Kaikki, joilla on autismediagnoosi</i>	82	94 % (87–97)	74 % (64–83)	93 % (85–97)

n = ryhmän vastaajamäärä. Sulkeissa 95 %:n luottamusväli. Kaksi viimeistä riviä ovat yhteenvedoja ylemmistä riveistä.

Laajan määritelmän mukainen puhelinkammo oli yleisin ryhmässä, jossa sekä ADHD että autismi on diagnosoitu (98 %), ja harvinaisin ryhmässä, jossa ei ole kumpaakaan (41 %).

Miten lukuja luetaan

Otos on itsevalikoitunut. Vastaajat päättivät itse vastata puheluja käsittelevään kyselyyn, ja kyselyä jaettiin ADHD- ja autismiyhteisöissä sekä yleisissä kanavissa. Ne, joille puhelu oli vaikeita, ovat voineet vastata muita todennäköisemmin. Prosenttiluvut kuvaavat näitä vastaajia, eivätkä ne kerro, kuinka yleistä puhelinkammo on väestössä. Ryhmien väliset erot ovat luotettavampia kuin yksittäiset prosenttiluvut.

Keitä vastaajat ovat

Taustatieto	Vastaajia
Kieliversio	suomi 443 · englanti tai ruotsi 21
Asuinalue	Suomi 453 · Suomen ulkopuolella 11
Ikä	18–24: 31 · 25–34: 95 · 35–44: 178 · 45–54: 129 · 55 tai yli: 31
Sukupuoli	nainen 302 · mies 121 · muunsukupuolinen 26 · ei halua sanoa 15
ADHD	diagnosoitu 166 · epäilty 163 · ei 135
Autismi	diagnosoitu 82 · epäilty 223 · ei 159
Ahdistuneisuus	diagnosoitu 175 · epäilty 128 · ei 161

Mitä vastaajat vastasivat

Niiden osuus kaikista 464 vastaajasta, jotka vastasivat usein tai aina. Luvun alla on 95 %:n luottamusväli.

Kun puhelin soi

Kysymys	Osuus vastaajista
1. Kun puhelimeni soi, jännitän tai ahdistun.	56 % 52–61
2. Ahdistun ennen puhelua, joka minun on soitettava.	64 % 59–68
3. Kuinka paljon puhelut kaiken kaikkiaan ahdistavat sinua? (0 = ei lainkaan, 10 = erittäin paljon)	60 % 7 tai enemmän · 56–65

Mitä teet asialle

Kysymys	Osuus vastaajista
4. Jätän vastaamatta tuttujen ihmisten puheluihin sen takia, miltä puhelut minusta tuntuvat.	26 % 22–30
5. Lykkään takaisin soittamista päivän tai pidempään.	39 % 34–43
6. Olen viimeisen vuoden aikana vältellyt jotain tärkeää (ajanvarausta, laskua, työpaikkaa, terveysasiaa), koska se olisi vaatinut puhelun.	76 % kyllä · 72–80
7. Vastaan puheluihin tuntemattomista numeroista.	23 % 20–27

Aika ja lopettaminen

Kysymys	Osuus vastaajista
8. Puhelun aikana minulta katoaa käsitys siitä, kuinka kauan puhelu on kestänyt.	39 % 35–44
9. Puhelun lopettaminen on minulle vaikeaa, vaikka haluaisin lopettaa.	33 % 29–37

Kun et tiedä, mitä odottaa

Kysymys	Osuus vastaajista
10. Ahdistun, kun en tiedä, miksi joku soittaa.	54 % 49–58
11. Ahdistun, kun en tiedä, kuinka kauan puhelu kestää.	32 % 28–36

Mieltymys

Kysymys	Osuus vastaajista
12. Jos saan valita, viestittelen mieluummin kuin soitan.	74 % 70–78

Näin luvut on laskettu

Esirekisteröinti

Määritelmät, katkaisuhetki ja poissulkusäännöt kirjattiin Open Science Framework -palveluun 28.9.2026, ennen tiedonkeruun alkua: <https://osf.io/8t473>.

Mukana olevat vastaukset

Kaikki 464 vastausta, jotka saapuivat ennen katkaisuhetkeä. Kolme rekisteröityä laatusääntöä ei poistanut yhtään vastausta: testilähetystyksiä ei ollut, mikään istuntokoodi ei esiintynyt kahdesti, eikä yhdenkään vastauksen aktiivinen vastausaika jäänyt alle 45 sekunnin (lyhin oli 76 sekuntia). Jokainen vastaus on täydellinen, koska kyselyä ei voi lähettää, jos pakollinen kysymys on vastaamatta. Kolme vastausta lähetettiin tilanteessa, jossa bottitarkistusta ei voitu tehdä, ja yksi vastaaja kertoi vastanneensa kyselyyn aiemmin. Rekisteröinnin mukaisesti nämä vastaukset ovat mukana luvuissa. Kummankaan ryhmän poisjättäminen ei muuta yhtäkään päälukua puolta prosenttiyksikköä enempää.

Luottamusvälit ja pienet ryhmät

95 %:n luottamusvälit on laskettu Wilsonin menetelmällä. Rekisteröinnin mukaan alle kymmenen vastaajan solut jätetään julkaisematta. Tässä sääntöä sovelletaan niin, että lukuja ei esitetä alle kymmenen vastaajan ryhmistä ja alle kymmenen vastaajan taustaluokat on yhdistetty.

Mitä ei vielä ole tehty

Tämä katsaus esittää vain osuudet luottamusväleineen. Rekisteröidyt hypoteesit (H1–H5) testataan ensimmäisen aallon aineistolla. Rekisteröity tavoite on vähintään 300 vastaajaa kussakin neljästä hypoteesiryhmästä (vain ADHD, vain autismi, AuDHD ja ei kumpaakaan). Nyt niissä on 21–79 vastaajaa.

Eettinen ennakkoarviointi

Kysely on anonyymi, ei tallenna henkilötietoja, ei sisällä interventtiä ja on avoin vain täysi-ikäisille. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden mukaan tällainen tutkimus ei edellytä eettistä ennakkoarviointia, eikä sitä haettu.

Rajoitukset

- Otos on itsevalikoitunut, joten luvut eivät ole väestöarvioita.
- Kaikki tiedot ovat vastaajien omia ilmoituksia. Diagnoseja ei ole varmennettu.
- 443 vastaajaa 464:stä vastasi suomenkieliseen versioon, joten tulokset kuvaavat toistaiseksi lähinnä suomeksi vastanneita.
- Pienten ryhmien luvut ovat epätarkkoja. Esimerkiksi ryhmässä ”vain autismi” on 21 vastaajaa.
- Muut kuin ASRS-seulan kysymykset on käännetty terminologia tarkistaen mutta ilman takaisinkäännöstä, mikä rajoittaa kieliversioiden vertailtavuutta.
- Kysely on kertaluonteinen poikkileikkaus, eikä siitä voi päätellä syy-seuraussuhteita.

Mitä seuraavaksi

Kysely on edelleen auki osoitteessa research.maximized-impact.org/study7. Ensimmäinen aalto päättyy 31.10.2026 klo 23.59 Suomen aikaa. Sen tulokset julkaistaan täydennyksenä 1 (Addendum 1) julkaisuun "The Case for Health Communications Technology" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.21978705>).

Luvut voivat muuttua, kun vastauksia kertyy lisää. Tätä katsausta ei käytetä sen päättämiseen, milloin tiedonkeruu lopetetaan.

Avoin aineisto ja koodi

Tämän katsauksen anonymisoitu aineisto ja koodi, jolla jokainen tässä esitetty tulos voidaan laskea aineistosta uudelleen, julkaistaan raportin mukana osoitteessa research.maximized-impact.org/study7/results CC BY 4.0 -lisenssillä. Aineistosta on jätetty pois ikäryhmä, sukupuoli, asuinalue ja kieli aina, kun sama yhdistelmä on alle kymmenellä vastaajalla. Siksi edellä esitettyjä taustatietojen lukumääriä ei voi laskea aineistosta. Lähetysaikoja ei ole aineistossa.

Sidonnaisuudet ja rahoitus

Tekijä on kehittänyt Yapper Phone -sovelluksen, joka on kaupallinen sovellus. Kyselyn vapaaehtoiset työkalut (puheluajastin, keskittymisäännet ja aikamerkit) on mukailtu siitä. Tutkimus mittaa ongelman yleisyyttä. Se ei esitä väitteitä sovelluksesta eikä käytä sitä interventiona. Institute for The Study Of Humanity -tutkimusohjelmaa rahoitetaan osittain sovelluksen voitoilla Maximized Impact ry:n kautta. Maximized Impact ry on suomalainen rekisteröity yhdistys, jota ei voi myydä eikä muuttaa voittoa tavoittelevaksi. Rahoitus: Maximized Impact ry. Ulkopuolista rahoitusta ei ole.

Viittaaminen ja yhteystiedot

Vakkilainen, J. (2026). Study 7 - Stage A: väliraportti. Institute for The Study Of Humanity. Esirekisteröinti: <https://osf.io/8t473>.

Kysymykset: janne@maximized-impact.org. Raportti on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.

Institute for The Study Of Humanity

Tutkimusohjelma, jota ylläpitää suomalainen rekisteröity yhdistys Maximized Impact ry. Helsinki.
research.maximized-impact.org

Liite: jokainen kysymys ryhmittäin

Usein tai aina vastanneiden osuus prosentteina (kysymys 3: 7 tai enemmän, kysymys 6: kyllä). Sulkeissa on 95 %:n luottamusväli. K1–K12 viittaavat edellä numeroituihin kysymyksiin.

Ryhmä	n	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Kaikki vastaajat	464	56 (52–61)	64 (59–68)	60 (56–65)	26 (22–30)	39 (34–43)	76 (72–80)
ADHD diagnosoitu, autismi diagnosoitu (AuDHD)	48	81 (68–90)	92 (80–97)	94 (83–98)	40 (27–54)	58 (44–71)	96 (86–99)
ADHD diagnosoitu, autismi epäilty	88	74 (64–82)	74 (64–82)	75 (65–83)	45 (35–56)	56 (45–66)	84 (75–90)
ADHD diagnosoitu, ei autismia (vain ADHD)	30	43 (27–61)	60 (42–75)	50 (33–67)	17 (7–34)	30 (17–48)	73 (56–86)
ADHD epäilty, autismi diagnosoitu	13	62 (36–82)	77 (50–92)	77 (50–92)	15 (4–42)	69 (42–87)	85 (58–96)
ADHD epäilty, autismi epäilty	100	62 (52–71)	71 (61–79)	68 (58–76)	27 (19–36)	39 (30–49)	78 (69–85)
ADHD epäilty, ei autismia	50	30 (19–44)	38 (26–52)	30 (19–44)	18 (10–31)	24 (14–37)	62 (48–74)
Ei ADHD:ta, autismi diagnosoitu (vain autismi)	21	81 (60–92)	90 (71–97)	81 (60–92)	33 (17–55)	43 (24–63)	81 (60–92)
Ei ADHD:ta, autismi epäilty	35	66 (49–79)	83 (67–92)	74 (58–86)	23 (12–39)	49 (33–64)	89 (74–95)
Ei ADHD:ta, ei autismia (ei kumpaakaan)	79	24 (16–35)	27 (18–37)	23 (15–33)	4 (1–11)	9 (4–17)	53 (42–64)
<i>Kaikki, joilla on ADHD-diagnoosi</i>	166	70 (63–77)	77 (70–82)	76 (69–82)	39 (31–46)	52 (44–59)	86 (79–90)
<i>Kaikki, joilla on autismidiagnoosi</i>	82	78 (68–86)	89 (80–94)	88 (79–93)	34 (25–45)	56 (45–66)	90 (82–95)

Ryhmä	n	K7	K8	K9	K10	K11	K12
Kaikki vastaajat	464	23 (20–27)	39 (35–44)	33 (29–37)	54 (49–58)	32 (28–36)	74 (70–78)
ADHD diagnosoitu, autismi diagnosoitu (AuDHD)	48	19 (10–32)	56 (42–69)	67 (53–78)	83 (70–91)	54 (40–67)	88 (75–94)
ADHD diagnosoitu, autismi epäilty	88	22 (14–31)	50 (40–60)	42 (32–52)	76 (66–84)	50 (40–60)	78 (69–86)
ADHD diagnosoitu, ei autismia (vain ADHD)	30	23 (12–41)	47 (30–64)	23 (12–41)	37 (22–54)	10 (3–26)	57 (39–73)
ADHD epäilty, autismi diagnosoitu	13	31 (13–58)	54 (29–77)	46 (23–71)	77 (50–92)	54 (29–77)	100 (77–100)
ADHD epäilty, autismi epäilty	100	24 (17–33)	37 (28–47)	36 (27–46)	56 (46–65)	34 (25–44)	80 (71–87)
ADHD epäilty, ei autismia	50	34 (22–48)	26 (16–40)	12 (6–24)	28 (17–42)	12 (6–24)	64 (50–76)
Ei ADHD:ta, autismi diagnosoitu (vain autismi)	21	0 (0–15)	43 (24–63)	52 (32–72)	86 (65–95)	62 (41–79)	95 (77–99)
Ei ADHD:ta, autismi epäilty	35	14 (6–29)	26 (14–42)	37 (23–54)	57 (41–72)	29 (16–45)	89 (74–95)
Ei ADHD:ta, ei autismia (ei kumpaakaan)	79	29 (20–40)	27 (18–37)	6 (3–14)	18 (11–28)	6 (3–14)	51 (40–61)
<i>Kaikki, joilla on ADHD-diagnoosi</i>	166	21 (16–28)	51 (44–59)	46 (38–53)	71 (64–77)	44 (37–52)	77 (70–83)
<i>Kaikki, joilla on autismidiagnoosi</i>	82	16 (10–25)	52 (42–63)	60 (49–70)	83 (73–90)	56 (45–66)	91 (83–96)